MINISTERIO DE SALUD

No. 120-2024/MINSA

REPUBLICA DEL PERU

Resolución Ministerial

Lima, 19 de FEBRERO del 2024

M. MENDOCILLA

L. QUIROZ

M. QUISPE G.

C. DIAZ V.

C. MARTINEZ V.

Visto, el Expediente N° DGIESP20230000406, que contiene el Informe N° 176-2022-DSAME-DGIESP/MINSA, el Memorando N° D001603-2023-DGIESP-MINSA que adjunta la Nota Informativa N° D000225-2023-DGIESP-DSAME-MINSA, el Memorándum N° D003062-2023-DGIESP-MINSA que adjunta el Informe N° D000200-2023-DGIESP-DSAME-MINSA, el Memorándum N° D004180-2023-DGIESP-MINSA que adjunta el Informe N° D000289-2023-DGIESP-DSAME-MINSA, y el Memorándum N° D004856-2023-DGIESP-MINSA que adjunta el Informe N° D000348-2023-DGIESP-DSAME-MINSA, de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública; y, el Informe N° D001191-2023-OGAJ-MINSA, de la Oficina General de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, los numerales I y II del Título Preliminar de la Ley N° 26842, Ley General de Salud, señalan que la salud es condición indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo. La protección de la salud es de interés público. Por tanto, es responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla;

Que, el numeral V del Título Preliminar de la precitada Ley, modificado por la Quinta Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, establece que es responsabilidad del Estado vigilar, cautelar y atender los problemas de salud mental de la población, entre otros;

Que, el numeral 1) del artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, señala como ámbito de competencia del Ministerio de Salud, la salud de las personas;

Que, los literales b) y h) del artículo 5 del precitado Decreto Legislativo, modificado por el Decreto Legislativo N° 1504, Decreto Legislativo que fortalece al Instituto Nacional de Salud para la prevención y control de las enfermedades, señalan que son funciones rectoras del Ministerio de Salud formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política nacional y sectorial de promoción de la salud, vigilancia, prevención y control de las enfermedades, recuperación, rehabilitación en salud, tecnologías en salud y buenas prácticas en salud, bajo su competencia, aplicable a todos los niveles de gobierno; así como, dictar normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución y supervisión de la política nacional y políticas sectoriales de salud, entre otros;

M. GUTIERREZ

A. TENORIO T.

E. PEÑA

C. MESTAS

Que, el artículo 6 de la Ley N° 30947, Ley de Salud Mental, establece que, en salud mental, se considera prioritario: 1. El cuidado de la salud mental en poblaciones vulnerables: primera infancia, adolescencia, mujeres y adultos mayores, bajo un enfoque de derechos humanos, equidad de género, interculturalidad e inclusión social, que garanticen el desarrollo saludable y la mejor calidad de vida de las personas, familias y comunidades; 2. La implementación de servicios de atención de salud mental comunitaria, como componentes primordiales y esenciales de las redes integradas de salud; y, 3. La implementación del modelo de atención de salud mental comunitaria como eje estratégico de la política pública de salud mental;

Que, el artículo 7 de la citada Ley dispone que, en el marco de lo establecido por el artículo 7 de la Constitución Política del Perú, toda persona, sin discriminación alguna, tiene derecho a gozar del más alto nivel posible de salud mental. El Estado garantiza la disponibilidad de programas y servicios para la atención de la salud mental en número suficiente, en todo el territorio nacional; así como el acceso a prestaciones de salud mental adecuadas y de calidad, incluyendo intervenciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación;

Que, el artículo 63 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2017-SA, modificado por Decreto Supremo Nº 011-2017-SA, establece que la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública es el órgano de línea del Ministerio de Salud, dependiente del Viceministerio de Salud Pública, competente para dirigir y coordinar las intervenciones estratégicas en Salud Pública en materia de salud mental, entre otras;

Que, en ese sentido, la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública ha propuesto la Directiva Sanitaria para el Cuidado Integral de la Salud Mental de Gestantes y Madres de Niñas y Niños Menores de 5 años, cuya finalidad es contribuir a la respuesta del sistema de salud para el cuidado integral de la salud mental de gestantes y madres de niñas y niños menores de 5 años y mejora de su calidad de vida;

Estando a lo propuesto por la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública;

Con el visado de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, de la Dirección General de Operaciones en Salud, de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias, de la Dirección General de Personal de la Salud, de la Oficina General de Tecnologías de la Información, de la Oficina General de Asesoría Jurídica, del Despacho Viceministerial de Salud Pública y del Despacho Viceministerial de Prestaciones y Aseguramiento en Salud; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, modificado por la Ley N° 30895, Ley que fortalece la función rectora del Ministerio de Salud y por el Decreto Legislativo N° 1504, Decreto Legislativo que fortalece al Instituto Nacional de Salud para la prevención y control de las enfermedades; y, el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2017-SA, modificado mediante los Decretos Supremos N°011-2017-SA y N° 032-2017-SA;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la Directiva Sanitaria N° 155 -MINSA/DGIESP-2024 Directiva Sanitaria para el Cuidado Integral de la Salud Mental de Gestantes y Madres de Niñas y Niños Menores de 5 años, que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial y que se publica en la sede digital del Ministerio de Salud.

M. MENDOCILLA
L. QUIROZ
M. QUISPE C.
E. PEÑA
C. DIAZ V.
M. GUTIERREZ
C. MARTINEZ V.
A. TENORIO T.
C. MESTAS

MINISTERIO DE SALUD

No. 120-2024/MINSA

REPUBLICA DEL PERU

Resolución Ministerial

Lima, 19 de FEBRERO del 2024

Artículo 2.- Encargar a la Oficina de Transparencia y Anticorrupción de la Secretaría General la publicación de la presente Resolución Ministerial y su Anexo en la sede digital del Ministerio de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CÉSAR HENRY VÁSQUEZ SÁNCHEZ
Ministro de Salud

MINISTERIO DE SALUD · REPUBLICA DEL PERU · MINISTRO

M. MENDOCILLA

M. QUISPE G.

C. MARTINEZ V.

O. DIAZ V.

L. QUIROZ

M. GUTIERREZ

A. TENORIO T.

E. PEÑA

C. MESTAS

DIRECTIVA SANITARIA Nº 155 - MINSA/DGIESP-2024

DIRECTIVA SANITARIA PARA EL CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD MENTAL DE GESTANTES Y MADRES DE NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS

I. FINALIDAD

Contribuir a la respuesta del sistema de salud para el cuidado integral de la salud mental de gestantes y madres de niñas y niños (MNN) menores de 5 años y mejora de su calidad de vida.

II. OBJETIVO

Establecer disposiciones técnicas para el cuidado de la salud mental de gestantes y MNN menores de 5 años.

III. ÁMBITO DE APLICACIÓN

La presente Directiva Sanitaria es de obligatorio cumplimiento en todos los establecimientos de salud (EESS) del Ministerio de Salud (MINSA), a cargo de las Direcciones de Redes Integradas de Salud (DIRIS); y de los Gobiernos Regionales, a cargo de las Direcciones Regionales de Salud (DIRESA), Gerencias Regionales de Salud (GERESAS), o las que hagan sus veces, bajo sus jurisdicciones. Es referencial para los demás EESS públicos y privados a nivel nacional.

IV. BASE LEGAL

- Ley Nº 26842, Ley General de Salud, y sus modificatorias.
- Ley Nº 29414, Ley que establece los derechos de las personas usuarias de losservicios de salud.
- Ley N° 29459, Ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productossanitarios.
- Ley Nº 29973, Ley General de las Personas con Discapacidad, y sus modificatorias.
- Ley Nº 30947, Ley de Salud Mental, y sus modificatorias.
- Decreto Supremo Nº 020-2014-SA, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud.
- Decreto Supremo Nº 007-2020-SA, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento dela Ley Nº 30947, Ley de Salud Mental.
- Decreto Supremo Nº 005-2021-SA, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 30421, Ley Marco de Telesalud, y del Decreto Legislativo Nº 1490, Decreto Legislativo que fortalece los alcances de la Telesalud.
- Decreto Supremo N° 008-2021-MIMP, Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional Multisectorial para las Niñas, Niños y Adolescentes al 2030.

- Resolución Ministerial Nº 751-2004/MINSA, que aprueba la NT N° 018-MINSA/DGSP-V.01 "Norma Técnica del Sistema de Referencia y Contrarreferencia de los Establecimientos del Ministerio de Salud".
- Resolución Ministerial Nº 827-2013/MINSA, que aprueba la NTS N° 105-MINSA/DGSP-V.01 "Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de Salud Materna".
- Resolución Ministerial Nº 496-2016/MINSA, que aprueba la Directiva Sanitaria N º 071-MINSA/CDC-V.01 "Directiva Sanitaria para la Vigilancia de Problemas de la Salud Mental Priorizados en establecimientos de salud centinela y mediante Encuesta Poblacional".
- Resolución Ministerial Nº 007-2017/MINSA, que aprueba la NTS N° 130-MINSA/2017/DGIESP Norma Técnica de Salud para la Atención Integral y Diferenciada de la Gestante Adolescente durante el Embarazo, Parto y Puerperio.
- Resolución Ministerial Nº 366-2017/MINSA, que aprueba el Documento Técnico: "Lineamientos de Política de Promoción de la Salud en el Perú".
- Resolución Ministerial Nº 935-2018/MINSA, que aprueba el Documento Técnico: Lineamientos de Política Sectorial en Salud Mental.
- Resolución Ministerial N° 670-2019/MINSA que aprueba el Petitorio Nacional Único de Dispositivos Médicos Esenciales para el Sector Salud.
- Resolución Ministerial Nº 030-2020/MINSA, que aprueba el Documento Técnico "Modelo de Cuidado Integral de Salud por Curso de Vida para la Persona, Familia y Comunidad (MCI)".
- Resolución Ministerial Nº 117-2020/MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa Nº 285-MINSA-2020-DIGTEL: "Directiva para la implementación y desarrollo de los servidores de telemedicina síncrona y asíncrona".
- Resolución Ministerial Nº 670-2021/MINSA, que aprueba la "Guía Técnica para el cuidado de la salud mental en mujeres en situación de violencia ocasionada por la pareja o expareja".
- Resolución Ministerial N° 136-2023-MINSA, que aprueba la Guía Técnica: Guía de Práctica Clínica paraTamizaje, Diagnóstico y Tratamiento de la Depresión en Personas Mayores de 18 años desde el Primer Nivel de Atención.
- Resolución Ministerial N° 633-2023-MINSA que aprueba el Documento Técnico: Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales para el Sector Salud.

V. DISPOSICIONES GENERALES

5.1 DEFINICIONES OPERATIVAS

- **Conducta autolesiva:** Cualquier daño intencional hecho por la persona contra sí misma, independientemente de la intención suicida.
- **Crisis de salud mental:** Es un estado temporal de alteración y desorganización de las funciones mentales y del comportamiento de la persona producto de una situación inesperada vivenciada como amenaza y que parece imposible de resolver.

- **Depresión postparto:** Es un trastorno mental afectivo que puede presentarse en las mujeres durante los primeros 4 meses tras el nacimiento de su bebé.
- **Emergencia psiquiátrica:** Toda condición repentina e inesperada, asociada a un problema de salud mental, que requiere atención inmediata al poner en peligro inminente la vida, la salud o que puede dejar secuelas invalidantes en la usuaria.
- **Equipo de salud mental:** Está conformado como mínimo por 2 profesionales de salud (El/la médico especialista en psiquiatría o el/la médico de familia o el/la médico cirujano y psicólogo) y además por otros profesionales de diferentes disciplinas del EESS (enfermero/a, químico farmacéutico, trabajador/a social, tecnólogo médico) que atiende a los usuarios, mediante intervenciones colaborativas, permitiendo armonizar sus conocimientos para elaborar un plan de intervenciones centrado en sus problemas de salud mental, necesidades y potencialidades para lograr su recuperación.
- **Periodo perinatal en la gestante y recién nacido:** Periodo que se inicia desde las 22 semanas de gestación (feto con 1000 gramos o más) hasta antes de los 7 días (antes de las 168 horas completas) de vida.
- **Plan de atención individualizado (PAI):** Comprende el conjunto de intervenciones planificadas a partir de los problemas identificados en la persona usuaria, necesidades y recursos tras la evaluación y diagnóstico realizado por el equipo de salud mental tratante del Centro de Salud Mental Comunitaria (CSMC) y consensuada con la persona usuaria y su cuidador(a). La ficha del PAI se encuentra descrita en la historia clínica y contiene: La determinación de necesidades y/o problemas, factores protectores, objetivos, intervenciones terapéuticas, responsables, seguimiento y evaluación.
- **Plan de continuidad de cuidados (PCC):** Es un documento que elabora el equipo de salud mental en el marco de la continuidad de cuidados con la participación de la persona usuaria (que ingresa al plan de continuidad de cuidados), el equipo de salud mental tratante y/o su cuidador(a), de manera conjunta donde se formula la planificación de múltiples intervenciones a realizar en base a necesidades, problemas y potencialidades identificados en la evaluación del usuario.
- **Problema psicosocial:** Son aquellas situaciones relacionales con la familia y/o entorno que ponen en riesgo la vida y la salud mental de la persona; pueden asociarse con situaciones de violencia, abandono socio familiar u otros que surgen en las interacciones interpersonales o provienen del entorno social.
- **Teleconsulta**: Es la consulta a distancia que se realiza entre un/a profesional de la salud y una persona usuaria mediante el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicación (TIC), con fines de promoción de la salud mental, prevención, diagnóstico, tratamiento, recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos, según sea el caso.
- **Teleinterconsulta**: Es la consulta a distancia mediante el uso de las TIC, que realiza un personal de la salud a un profesional de la salud para la atención de una persona usuaria, pudiendo ésta estar o no presente, con fines de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento, recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos, según sea el caso.
- **Trastorno mental y del comportamiento en la gestante y MNN menor de 5 años:** Condición mórbida que sobreviene en una mujer durante la gestación

o en MNN menores de 5 años, afectando en intensidades variables el funcionamiento de la mente, el comportamiento, el organismo, la personalidad y la interacción social.

5.2 ASPECTOS GENERALES PARA EL CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD MENTAL DE LAS GESTANTES Y MNN MENORES DE 5 AÑOS

- El cuidado de la salud mental de gestantes y MNN menores de 5 años se realiza en EESS de la comunidad donde vive, y que tenga el personal con competencias para hacerlo, así como en todos los servicios del EESS donde se atienda a las usuarias y a sus familias, en la cual se identifiquen sus signos y síntomas, y puedan ser tratado en el EESS o ser derivado a otra, según capacidad resolutiva.
- Las intervenciones son interdisciplinarias de acuerdo con el contexto y las necesidades diferenciales de la gestante y de la MNN menores de 5 años. Se incluyen intervenciones individuales y grupales.
- El/la profesional de la salud que brinda atención a gestantes y MNN menores de 5 años en los EESS incorpora en todos los procesos de atención a las usuarias y sus familiares, lo siguiente:
  - Trato cálido, escucha activa, diálogo respetuoso y receptivo a fin de favorecer el vínculo de confianza y seguridad con el personal de los servicios, permitirle expresarse y mejorar la identificación de posibles problemas de salud mental.
  - Respeto a la gestante y MNN menores de 5 años durante toda la atención en los EESS, y evita conductas humillantes, agresiones verbales y físicas y observaciones sexistas, a fin de prevenir la violencia obstétrica.
  - Evalúa las relaciones o vínculos de la usuaria e identifica la presencia y la calidad de la red de apoyo sociofamiliar, con el objetivo de favorecer su recuperación.
  - Realiza la búsqueda activa e identifica gestantes y MNN menores de 5 años víctimas de violencia o expuestas a sufrirlas, o con mayores dificultades para acceder a los servicios, tales como las pertenecientes a los pueblos originarios y afrodescendientes, mujeres que se encuentran en situación de exclusión social (analfabetismo, migrantes, entre otros), mujeres con discapacidad, adolescentes, entre otras.
  - Identifica y considera los cambios físicos y mentales de las usuarias a lo largo del embarazo, el puerperio y la lactancia, así como la variación en la dinámica familiar, en las demandas, expectativas y apoyo de la familia por la gestación y maternidad, respetando las creencias, cultura y los tiempos de la persona.
  - Identifica si las gestantes y MNN menores de 5 años están recibiendo las atenciones correspondientes en salud (atenciones prenatales, controles médicos, inmunizaciones, entre otros), orientándolas y asistiéndolas en caso se identifique que no está haciendo uso de dichos servicios.
- Las evaluaciones e intervenciones en salud mental se realizan en el marco de la atención de salud mental comunitaria, considerando los enfoques de derechos humanos, género, interseccionalidad, interculturalidad y curso de vida durante la atención al usuario:

- **Enfoque de derechos humanos:** Reconoce que el objetivo principal de toda intervención en el marco de esta Ley debe ser la realización de los derechos humanos, identificando a los titulares de derechos y aquello a lo que tienen derecho conforme a sus particulares necesidades; identificando, asimismo, a los obligados o titulares de deberes y de las obligaciones que les corresponden. Se procura se facilita una acción profesional preventiva, efectiva y oportuna mediante la valoración, categorización y gestión del riesgo.
- **Enfoque de género**: Reconoce la existencia de circunstancias asimétricas en la relación entre hombres y mujeres, construidas sobre la base de las diferencias de género que se constituyen en una de las causas principales de la violencia hacia las mujeres. Este enfoque debe orientar el diseño de las estrategias de intervención orientadas al logro de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
- **Enfoque de interseccionalidad:** Reconoce que la experiencia que las mujeres gestantes se ve influida por factores e identidades como su etnia, color, religión; opinión política o de otro tipo; origen nacional o social, patrimonio; estado civil, orientación sexual, condición de seropositiva, condición de migrante o refugiada, edad o discapacidad; y, en su caso, incluye medidas orientadas a determinados grupos de mujeres.
- **Enfoque de interculturalidad:** Reconoce la necesidad del diálogo entre las distintas culturas que se integran en la sociedad peruana, de modo que permita recuperar, desde los diversos contextos culturales, todas aquellas expresiones que se basan en el respeto a la otra persona. Este enfoque no admite aceptar prácticas culturales discriminatorias que toleran la violencia u obstaculizan el goce de igualdad de derechos entre personas de géneros diferentes.
- **Enfoque de curso de vida:** Aborda los momentos del continuo de la vida y reconoce que el desarrollo humano y los resultados en salud dependen de la interacción de diferentes factores a lo largo del curso de la vida, de experiencias acumulativas y situaciones presentes de cada individuo influenciadas por el contexto familiar, social, económico, ambiental y cultural; entendiendo que invertir en atenciones oportunas en cada generación repercutirá en las siguientes y que el mayor beneficio de un momento vital puede derivarse de intervenciones hechas en un período anterior.

- El/la profesional de la salud es capacitado/a para implementar la presente Directiva Sanitaria; las capacitaciones son incorporadas en los Planes de Desarrollo de Personal (PDP) de las DIRIS, DIRESA y GERESA.

VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS: DESARROLLO DE ACCIONES DE CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD MENTAL PARA LAS GESTANTES Y MNN MENORES DE 5 AÑOS

6.1 PARA EL CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD MENTAL DE GESTANTES Y MNN MENORES DE 5 AÑOS

Infraestructura adecuada

- Las Direcciones Regionales de Salud, Gerencia de Salud y Direcciones de Redes Integradas de Salud garantiza un ambiente de atención en los EESS con características de privacidad, confidencialidad y seguridad, así

mismo está debidamente ventilado y tiene consideraciones arquitectónicas de accesibilidad para personas con discapacidad.

Materiales e instrumentos

- Equipamiento: Mobiliario y útiles de escritorio, equipo multimedia, televisores, computadoras, impresoras, servicio de internet, teléfono fijo o celular.
- Instrumentos médicos.
- Material comunicacional.
- Instrumentos de tamizaje:
    - Cuestionario sobre la salud del paciente-9 (PHQ-9, por sus siglas eninglés) – (Anexo 1).
    - Guía de preguntas para el tamizaje de violencia a mujeres en situación de violencia de pareja o expareja (WAST, por sus siglas en inglés) - (Anexo 2).
    - Cuestionario de Identificación de los trastornos debidos al consumo de alcohol (AUDIT-C), por sus siglas en inglés (Anexo 3).

Recursos humanos:

- El equipo de salud mental (médico psiquiatra, médico de familia, médico cirujano, psicólogo/a, enfermero/a, químico farmacéutico o trabajador/a social) de los EESS brinda el cuidado de la salud mental durante el proceso de atención a las gestantes y MNN menores de 5 años.

6.2 ACTIVIDADES SEGÚN NIVEL DE ATENCIÓN

6.2.1 EESS del primer nivel de atención no especializados en salud mental

El/la profesional de la salud, de acuerdo a sus competencias, incorpora en las atenciones que realizan a gestantes y MNN menores de 5 años el cuidado integral de la salud mental a través de actividades de promoción de la salud, prevención, detección, evaluación, diagnóstico, tratamiento y recuperación en la salud mental.

1) En los servicios de atención prenatal o CRED, el/la profesional obstetra o el/la licenciado/a en enfermería con competencias.
    - Aplica los tamizajes PHQ-9, WAST y AUDIT-C a todas las usuarias gestantes yMNN menores de 5 años según corresponda, consignándose los resultados en la historia clínica de la usuaria gestante.
    - Brinda consejería sobre salud mental a todas las gestantes y MNN menores de 5 años, independiente al resultado de los tamizajes.
    - Registra las actividades de tamizaje y las consejerías en la historia clínica de lausuaria y en el sistema de registro de atenciones.
    - Realiza la derivación o la referencia para la evaluación en el servicio de medicina y psicología de las gestantes y/o MNN menores 5 años con tamizaje positivo, según corresponda (ver numeral 2).
2) El/la médico cirujano o psicólogo/a brinda atención en salud mental a las usuarias con tamizaje positivo (PHQ-9, WAST y AUDIT-C), diagnosticando y

ofreciendo intervención terapéutica (psicofármacos y/o psicoterapia), de acuerdo a sus competencias.

3) El/la médico cirujano realiza tele interconsultas con un/a médico especialista en psiquiatría del CSMC o del hospital de su ámbito territorial para coordinar laevaluación, intervención o referencia que sea necesaria en la atención de la salud mental de gestantes y MNN menores de 5 años.
4) El/la médico cirujano (o en su ausencia el/la profesional de salud que atiende el caso) realiza la referencia a otro ESSS del primer nivel, CSMC de su jurisdicción o al hospital con servicios de salud mental, en los casos de no contar con la capacidad resolutiva para la intervención, no presentar mejoría clínica o en caso de una emergencia en salud mental. Una vez resuelto el motivo de referencia y realizada la contrarreferencia, el EESS del primer nivel de atención continúa con la atención de la usuaria de acuerdo con las indicaciones y recomendaciones brindadas por el personal especializado en salud mental (médico(a) especialista en psiquiatría y/o psicólogo/a).
5) El/la profesional de la salud que atiende a la paciente, encoordinación con el personal responsable de vigilancia de salud mental o quien haga sus veces en los EESS seleccionados como EESS centinela realiza la notificación de la vigilancia centinela en casos detectados de intento de suicidio, episodio depresivo moderado y grave, y primer episodio psicótico.
6) El/la trabajador/a social, licenciado/a de enfermería u otro/a profesional designado/aarticula con los servicios del Estado que brindan atención a mujeres en situaciónde violencia (Centro Emergencia Mujer-CEM, comisarías, fiscalías u otras), y moviliza las redes de apoyo psicosocial (agentes comunitarios de salud y organizaciones de la comunidad), a fin de desarrollar actividades que van desde la prevención, promoción de la salud tratamiento y recuperación a favor de las gestantes y MNN menores de 5 años.

M. QUISPE G.

En el marco de las actividades de acompañamiento clínico psicosocial, el/la jefe del EESS coordina y articula con el CSMC de su jurisdicción para asegurar la continuidad de cuidados de salud de las usuarias.

6.2.2 En el CSMC

El personal de salud del CSMC realiza las siguientes actividades:

- Acoge, recibe a mujeres gestantes y MNN menores de 5 años que son referidas por un problema de salud mental de moderado a severa intensidad, así como aquellos casos que acuden directamente.
- Realiza las evaluaciones e intervenciones correspondientes.

C. DIAZ M.

- Brinda atención ambulatoria especializada, evalúa integralmente y determina los diagnósticos en torno a los trastornos mentales y del comportamiento y los problemas psicosociales que presente la usuaria, de acuerdo con su competencia profesional, ofreciendo intervención terapéutica (psicofarmacológicas, psicoterapéuticas y/o psicosociales).
- Formula el PAI y el PCC en el caso de que la usuaria padezca un trastorno mental grave o problema psicosocial complejo.

MINISTERIO DE SALUD - DGIESP - DIRECTORA EJECUTIVA

- Realiza el llenado de las fichas de registro de notificación de la vigilancia centinela en casos detectados de intento de suicidio, episodio depresivo moderado o grave, o primer episodio psicótico, en coordinación con el personal responsable de la vigilancia en salud mental o quien haga sus veces

del EESS, que permita contar con información epidemiológica de los casos para toma de decisiones, para la gestión clínica y operativa de los servicios de salud mental.

- Realiza la atención oportuna de las usuarias que se encuentran en emergencia psiquiátrica, toma las medidas necesarias para asegurar la adecuada valoración médica de las usuarias, su tratamiento o la estabilización de sus condiciones generales en caso necesiten ser transferidas. Cuando los recursos del EESS no permiten brindar la atención especializada que la usuaria requiera, se procede a referirla según la NT Nº 018-MINSA/DGSP-V.01 "Norma Técnica del Sistema de Referencia y Contrarreferencia de los Establecimientos del Ministerio de Salud", aprobada por Resolución Ministerial N°751-2004 MINSA o la que haga sus veces.
- Realiza la contrarreferencia al EESS de origen de los casos considerados no graves y/o no complejos y de aquellos casos graves y/o complejos que han cumplido con los objetivos terapéuticos trazados, brindando las recomendaciones y asistencia técnica para la continuidad de los cuidados respectivos.
- Realiza asistencia técnica, supervisión y capacitación al personal de los EESS de primer nivel de atención de su territorio para la mejora de las intervenciones clínicas, psicosociales y de gestión en salud mental de gestantes y MNN menores de 5 años.
- Articula acciones con los actores sociales de la comunidad para el cuidado de la salud mental de gestantes y MNN menores de 5 años.

6.2.3 II y III nivel de atención

1. El/la médico especialista en psiquiatría o el/la médico de familia o el/la médico cirujano, según corresponda, brinda atención (evaluación, diagnóstico y tratamiento) a gestantes y MNN menores de 5 años con problemas de salud mental, en las Unidades Productoras de Servicios deSalud (UPSS) o servicios de salud mental.
2. En los casos que la gestante y la MNN menor de 5 años, tenga un trastorno mental leve, se realiza la coordinación con los EESS del primer nivel de atención no especializada; y, en los casos de trastorno mentales de severidad moderada o compleja, se realiza la coordinación con el CSMC de la RIS o Red de Salud para la continuidad de su tratamiento.
3. En caso que la usuaria necesite hospitalización por un problema de salud mental, el/la médico especialista en psiquiatría o el/la médico de familia o el/la médico cirujano, según corresponda, indica el ingreso hospitalario a las unidades de hospitalización de salud mental o a la que haga sus veces; el ingreso a hospitalización puede darse por emergencias (en caso de emergencia psiquiátrica), programada o intrahospitalaria (en caso sea derivada desde otra UPSS del mismo EESS).
4. El/la médico especialista en psiquiatría o el/la médico de familia o el/la médico cirujano, según corresponda, solicita el consentimiento informado de la usuaria para todo internamiento u hospitalización por problemas de salud mental, exceptuando las situaciones de emergencias psiquiátricas en las que no pueda expresarlo pese a los esfuerzos para obtenerlo, y en los que no se cuente con un representante legal o apoyo para la toma de decisiones. Una vez resuelta la situación de emergencia, cualquier diagnóstico, tratamiento,

procedimiento, internamiento u hospitalización requiere necesariamente de su consentimiento informado.

5. El equipo de hospitalización brinda facilidades a las usuarias que se encuentran internadas en la unidad de hospitalización por problemas de salud mental y tienen hijos/as menores de 1 año, para recibir las visitas de estos, previa evaluación individualizada y autorización del/de la médico responsable del caso y en coordinación con la familia, con la finalidad de no interrumpir el proceso de apego y vínculo.
6. El/la médico especialista en psiquiatría o el/la médico de familia o el/la médico cirujano, según corresponda, realiza las interconsultas a las diferentes especialidades que requiera la usuaria para mantener o mejorar su salud durante el periodo de hospitalización.
7. El/la médico especialista en psiquiatría o el/la médico de familia o el/la médico cirujano, según corresponda, realiza la contrarreferencia de la usuaria al EESS de menor capacidad resolutiva una vez que se haya resuelto el motivo por el cual fue hospitalizada, para garantizar la continuidad del cuidado.
8. Los/as profesionales de la salud de los Módulos de Atención al Maltrato Infantil y del Adolescente en Salud (MAMIS) Brindan atenciones a las usuarias gestantes o MNN menores de 5 años edad víctimas de violencia, en caso que el hospital cuente con estos módulos de atención.

6.3 PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE PROBLEMAS DE SALUD MENTAL EN GESTANTES Y MNN MENORES DE 5 AÑOS

El personal de la salud realiza las siguientes acciones:

Tabla 1-A: Fortalecimiento del autocuidado de la salud mentalmaterna	El personal de la salud recomienda a las usuarias: - Recurrir a información de fuentes confiables, como la brindada por el personal de la salud del EESS o por el MINSA. - Resolver sus dudas con el/la profesional de la salud y seguir las indicaciones. - Expresar sus dudas, emociones y expectativas con respecto al presente y futuro con la/s persona/s de su confianza. - Establecer y mantener contacto con una red social de apoyo: Personas con las que la usuaria sienta confianza, seguridad y disponibilidad (estos pueden ser familiares, amistades, grupos de pares, entre otros). - Realizar ejercicio físico regularmente de acuerdo a la condición de salud de la usuaria según indicación del personal de la salud. - Tener una alimentación balanceada de acuerdo a sus necesidades nutricionales. - Tener suficientes horas de descanso. - No automedicarse ni seguir recomendaciones de tratamientos de personas no profesionales. - Realizar actividades sociales, educativas y recreativas que fomenten la salud mental, incluyendo el manejo del estrés. - Informarse para hacer uso efectivo de los derechos establecidos por la Ley N° 26644, que precisa el goce del derecho a descanso pre-natal y post-natal de la trabajadora gestante y la Ley 27240, Ley que otorga permiso por lactancia materna. - Solicitar información haciendo uso de la Línea 113 opción 5 y otras líneas telefónicas de apoyo a la salud mental disponibles en la localidad.

M. QUISPE G.

C. DIAZ V.

: Tabla 1-B: Fortalecimiento de familias	Los/as profesionales de la salud recomiendan a la familia y persona cercana a la usuaria: - Preguntarle cómo se siente, invitarla a compartir sus emociones, pensamientos y problemas sin juzgar ni criticar, haciéndola sentir comprendida. - Conversar sobre las dudas en torno a la maternidad y el proyecto de vida. - Acompañarla a sus atenciones pre y postnatales, controles de crecimiento y desarrollo, servicios de salud mental, entre otros, si ellaasí lo desea. - Cumplir con las indicaciones del/de la profesional de salud para el cuidado de su salud. - Apoyar el hábito de la alimentación balanceada y la actividad física de acuerdo con etapa de gestación o maternidad, y los horarios de descanso adecuados. - Compartir las tareas domésticas de manera equilibrada entre los miembros de la familia. - Apoyar en la crianza de los/as hijos(as) menores, brindando un ambiente de seguridad y sensibilidad a sus necesidades. - Apoyar la presencia de una red de soporte social, a través del mantenimiento de la comunicación constante con pares, la participación en grupos de soporte, entre otros.

Tabla 1-C: Fortalecimiento de entornos saludables o promotores de la salud mental en la comunidad	El personal responsable de promoción de la salud en los EESS, con laparticipación activa de la comunidad: - Identifica en su territorio las necesidades de salud mental de las gestantes y MNN menores de 5 años y los problemas específicos en la comunidad que les afecte. - Impulsa a las autoridades y actores sociales claves a fortalecer el trabajo articulado y coordinado a nivel comunitario, con el objetivo de generar entornos positivos seguros (implementación de lactarios, clubes de madres, grupos de apoyo, grupos de soporte, desarrollo de espacios públicos saludables de juego para NN de 0 a 5 años y sus familias) para la recreación y deporte.

Tabla 2: Intervenciones preventivo- promocionales para la salud mental materna	El/la psicólogo/a realiza y coordina con los/as profesionales de salud del EESS el desarrollo sesiones o talleres grupales dirigidos a las gestantes y MNN menores de 5 años y a sus familiares en los siguientes temas: - Parentalidad positiva. - Pautas de crianza. - Apego y vínculo. - Los roles en el curso de vida y el enfoque de género. - Los proyectos de vida. - Habilidades de convivencia saludable en pareja. - Habilidades de convivencia saludable en el entorno familiar. - Resiliencia. Adicionalmente, como parte de su tratamiento, las gestantes y MNN menores 5 años con factores de riesgo (ver Tabla 3).

6.4 DETECCIÓN DE LOS TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES

6.4.1 Identificación de persona con trastorno mentales y del comportamiento y/o problemas psicosociales "Sospecha de caso"

- Todo/a profesional de salud del EESS que tenga contacto con gestantes o MNN menores de 5 años debe estar alerta de los posibles signos de alarma y factores de riesgo más frecuentes que se asocian a trastornos mentales y del comportamiento y/o problemas psicosociales (Tabla 3).

Tabla 3. Signos de alarma y factores de riesgo asociados a problemas de salud mental en gestantes y MNN menores de 5 años

Signos de alarma	Factores de riesgo
- Actitud poco comunicativa/expresiva. - Actitud sumisa frente a pareja o familiar. - Tristeza o fragilidad emocional notoria durante la conversación. - Visitas recurrentes al EESS pormúltiples problemas de salud. - Malestares físicos recurrentes lumbalgia, cefaleas. - Marcada aflicción o búsqueda reiterada de ayuda. - Aislamiento social u otros cambios conductuales recientes. - Varios días continuos de un estado de ánimo anormalmente alto o irritable, alto nivel de energía sobre lo habitual, y, que quizás, la puso en riesgo. - Cambios en el apetito, o en el patrón de sueño. - Dificultad para realizar actividades usuales: Laborales, escolares, domésticas o sociales. - Automedicación repetida para malestares emocionales o físicos. - Inicio o aumento en el consumo de alcohol yotras drogas. - Durante la gestación, rechazar el embarazo o actuar como si no estuviera embarazada. - Presencia de moretones, quemaduras o signos de autolesiones como cortes o cicatrices.	- Historia personal o familiar de problemas de salud mental. - Deficientes redes de apoyo familiar y social. - Relación conflictiva/violenta, o deficiente en apoyo y empatía con la pareja y/o la familia. - Víctima de violencia, incluyendo violencia sexual, reciente o en el pasado. - Bajo grado de instrucción. - Problemas financieros. - Dificultad de acceso a servicios de salud. - Antecedentes de parto prematuro, con bajo peso al nacer, malformaciones, riesgo de morir o que haya necesitado hospitalización. - Embarazo/maternidad en niña/adolescente o embarazo no deseado. - Incompleto o ausente control prenatal. - Enfermedades durante el embarazo. - Suspensión o dificultades con la lactancia materna. - Consumo de sustancias psicoactivas. - Antecedentes de eventos traumáticos

- Los servicios en los que debe priorizarse esta identificación son: Consultas ambulatorias de medicina, atenciones prenatales, servicio de planificación familiar, CRED, servicio de atención en adolescentes, entre otros.

6.4.2 Tamizajes

- Son realizados por el/la obstetra o el/la licenciado/a en enfermería con competencias a toda gestante y MNN menor de 5 años que acuden a los servicios de CRED y de atención prenatal. Se considera la aplicación de los tamizajes de acuerdo a la Tabla 4.

  Si el tamizaje resulta positivo se deriva a los servicios correspondientes de medicina y/o piscología para su abordaje. De no contar con el servicio competente en el EESS se deriva al EESS más cercano a su domicilio con los servicios para la atención del usuario.

  Si el tamizaje resulta negativo y, posteriormente, se identifican signos y síntomas de sospecha asociados a problemas de salud mental, puede aplicarse nuevamente antes del siguiente periodo establecido.

  Para la codificación de la actividad de tamizaje ver el Anexo 4.

6.4.3 Consejería de prevención de riesgos en salud mental

Luego de la toma de tamizaje, independientemente del resultado (positivo o negativo), el/la obstetra o el/la licenciado/a en enfermería brindan consejería de acuerdo a los hallazgos (refuerzo de factores protectores si el resultado es negativo o la derivación al servicio de salud mental del EESS, si la usuaria es identificada con algún problema de salud mental).

MINISTERIO DE SALUD Dirección General de Personal de la Salud M. QUISPE G.

MINISTERIO DE SALUD C. DIAZ V.

MINISTERIO DE SALUD - DGIESP Dirección de Salud Mental Med. Psiq. Judy Esther Castillero Peralta V°B° DIRECTORA EJECUTIVA

Tabla 4. Tamizajes en salud mental a gestantes y MNN menores de 5 años

CUESTIONARIO/ESCALA	CARACTERÍSTICAS	EN GESTANTE	EN MADRE DE NN MENORES 5AÑOS
CUESTIONARIO SOBRE LA SALUD DEL PACIENTE-9 **PHQ-9** **(Anexo 1)**	**Sirve para:** Cuestionario de 9 ítems que evalúa la presencia y gravedad de síntomas depresivos experimentados por las personas durante las semanas previas. **Lo aplica:** Profesional asistencial de los EESS de salud (médico cirujano, enfermero, obstetra, nutricionista, cirujano dentista, asistenta social, tecnólogo medico capacitados) **Interpretación de resultado:** • **Caso negativo: 0 – 4** • **Caso positivo:** ▪ **Síntomas leves: 5 – 9** ▪ **Síntomas moderados: 10 – 14** ▪ **Síntomas moderadamente severos: 15 – 19** ▪ **Síntomas severos: 20 - 27** Los casos positivos identificado como leves son tratados en el EESS de salud en el servicio de psicología, en cuanto a los casos de moderados a severos son referidos a los Centro de Salud Mental Comunitaria de la jurisdicción para su atención.	**Cuando se aplica:** en 2 momentos durante la gestación: -1er trimestre de gestación o primer contacto con gestante, y -3er trimestre de gestación. El cuestionario puede aplicarse nuevamente trascurrido 2 semanas de la última toma, sólo en caso que en la primera aplicación haya salido categoría "ninguna" y se observe posibles signos de alarma y factores de riesgo.	**Cuando se aplica:** • En puérperas: Aplicar antes del alta en caso no se haya aplicado anteriormente. • En MNN menores de 1año, aplicar en 2 momentos -Durante el primer mes de vida del/de la NN, y -A los 10 meses de vida del/de la niña o niño. • En MNN entre 1 y 5 años: Desde el primer contacto y mínimo 1 vez al año.

Guía de preguntas para el tamizaje de violencia amujeres en situación de violencia de pareja o expareja **WAST** **(Anexo 2)**	**Sirve para:** Cuestionario de 8 ítems que evalúa a) el grado de estrés existente en la relación; b) dificultad para resolver discusiones; y, c) existencia de episodios violentos a nivel emocional, psicológico, físico o sexual. **Lo aplica:** Profesional asistencial de los EESS de salud (médico cirujano, enfermero, obstetra, nutricionista, cirujano dentista, asistenta social, tecnólogo medico capacitados) **Interpretación de resultado:** • **Puntaje negativo: 8 a 14** • **Puntaje positivo: 15 a 24** Un puntaje menor no necesariamente la descarta presencia de violencia, pues si las preguntas 4,6 y 7 tienen puntaje 2 ó 3, se sospecha de violencia.	**Cuando se aplica:** en 2 momentos durante la gestación: -1er trimestre de gestación o primer contacto con gestante, y - 3er trimestre de gestación.	**Cuando se aplica:** • En puérperas: Aplicar antes del alta en caso no se haya aplicado anteriormente. • En MNN menores de 1año: Aplicar en 2 momentos en la atención: -Durante el primer mes devida del/de la NN. -En el décimo mes de vidadel/de la niña o niño. • En MNN entre 1 y 5 años: Aplicar desde el primer contacto y mínimo 1 vez al año durante la atención
Cuestionario de Identificación de los Trastornos debidos al Consumo de Alcohol **AUDIT-C** **(Anexo 3)**	**Sirve para:** Cuestionario de 3 ítems que sirve para determinar si el consumo de alcohol de una persona pueda considerase peligrosa. **Lo aplica:** Profesional asistencial de los EESS de salud (médico cirujano, enfermero, obstetra, nutricionista, cirujano dentista, asistenta social, tecnólogo medico capacitados) **Interpretación de resultado:** • **Puntaje negativo: 0 a 2** • **Puntaje positivo: 3 a 12** Un puntaje significativo "positivo" en MNN menores de 5 años indica que la persona está	**Cuando se aplica:** durante la gestación: -En el primer trimestre o primer contacto con la gestante.	**Cuando se aplica:** • En puérperas: Aplicar antes del alta en caso no se haya aplicado anteriormente. • En MNN menores de 1año: Aplicar 1 vez dentro del primer año de vida de la niña o niño. - Durante el primer mes de vida del/de la niña y niño o - -En el décimo mes de vida del/de

M. QUISPE G.

C. DIAZ V.

	en riesgo elevado de consumo perjudicial o abuso o dependencia de alcohol. En gestante cualquier pregunta con respuesta positiva indica que la persona está en riesgo elevado de consumo perjudicial o abuso o dependencia de alcohol.		la niña o niño. • En MNN entre 1 y 5 años: Desde el primer contacto y mínimo 1 vez al año.

M. QUISPE G.

C. DIAZ V.

6.5 INTERVENCIONES PARA EL DIAGNÓSTICO Y LA RECUPERACIÓN

6.5.1. Diagnóstico e Intervenciones recuperativas

a) Diagnóstico:

La realización del diagnóstico de trastornos mentales y del comportamiento y/o problemas de salud mental se hace a través de la evaluación clínica integral por parte del/la médico especialista en psiquiatría, médico especialista en medicina familiar o médico cirujano, según corresponda. Se considera el diagnóstico basado en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) – 10.

b) Planificación para la intervención según nivel de atención.

Primer nivel de atención no especializado

Las usuarias gestantes y MNN menores de 5 años, en las que el/la médico cirujano o psicólogo/a, de acuerdo a sus competencias profesionales y a las necesidades de salud de la usuaria, diagnostica un trastorno mental y del comportamiento y/o problema psicosocial de leve a moderada intensidad, reciben tratamiento según la necesidad encontrada.

Primer nivel de atención especializado (CSMC)

- Se realiza el PAI que incluye la evaluación del equipo de salud mental y participación de la familia.
- Se designa un responsable para gestantes y MNN menores de 5años que tienen un trastorno mental grave o problema psicosocial complejo, quien realiza seguimiento de la usuaria.
- El responsable planifica la elaboración, coordinación, programación y evaluación de las intervenciones de cuidado de la salud mental de la gestante y MNN menores de 5 años, así como las funciones y responsabilidades respecto al caso de cada integrante del equipo de salud mental.
- Las gestantes y/o MNN menores de 5 años que presenten un diagnóstico de trastorno mental grave, como psicosis perinatal, trastorno depresivo (moderado asevero), ansiedad grave, conducta suicida, recaída de trastorno por consumo de sustancias, y las víctimas de violencia, son priorizadas para ingresar al PCC del CSMC. El equipo interdisciplinario, realiza la evaluación según criterios establecidos, para la incorporación de la usuaria al PCC o para el alta según sea el caso.

Segundo y tercer nivel de atención

- El/la médico especialista en psiquiatría o medico/a de familia o médico cirujano o psicólogo/a, de acuerdo a sus competencias profesionales y a las necesidades de la usuaria, diagnostica un problema de salud mental (trastorno mental y del comportamiento y/o problema psicosocial) de manera integral y brinda el tratamiento correspondiente a la usuaria gestante y MNN menores de 5 años.
- Cuando la gestante cumpla con la atención brindada en el nivel II y III de manera satisfactoria, retorna al EESS de origen, asegurando la continuidad de cuidados.

c) Intervenciones psicosociales y psicoterapéuticas

Apoyan el funcionamiento psicosocial y facilitan los cambios para la mejora de la calidad de vida. Pueden ser individuales, familiares o grupales. Se realizan en el ámbito de los EESS, ámbito domiciliario o comunitario.

Dentro de estas intervenciones tenemos:

i. **Visitas domiciliarias:** Son visitas en el hogar de la usuaria realizadas por el/la trabajador/a social, el/la licenciado/a en enfermería, el/la psicólogo/a u otros/as profesionales, en las que se realiza las siguientes acciones:

- Evaluar el cuidado de la salud mental de la gestante o MNN menores de 5 años (seguimiento y cumplimiento de indicaciones médicas e identificación de la dinámica familiar).
- Brindar información sobre cómo mejorar las interacciones madre – hijo/a, sensibilidad materna y respuesta ante las necesidades de sus hijos/as.
- Identificar otras necesidades de la usuaria, como sociales y el acceso a servicios de educación.
- Incorporar elementos terapéuticos como la escucha activa, formación de metas, y resolución de problemas.

ii. **Intervenciones en la relación madre-hijo/a:** Se brinda consejería para construir interacciones de calidad entre las usuarias y sus hijos/as menores de 5 años, facilitar yresponder apropiadamente a las necesidades emocionales de su bebé, interacción física frecuente, comunicación verbal, hacer contacto visual, crear un entorno estimulante para el/la bebé a través de juguetes, imágenes y libros, contacto piel a piel en caso de lactantes, alimentación saludable, entre otros. Puede ser realizado por el personal de enfermería, trabajo social y psicología en los ambientes de los EESS o en domicilio de la usuaria, como parte de la promoción de la salud mental materna.

iii. **Grupo de Ayuda Mutua (GAM):** Dirigido a gestantes y/o MNN menores de 5 años que tienen antecedentes de trastornos mentales y del comportamiento y/o problemas psicosociales perinatales. Las usuarias voluntariamente comparten experiencias que deseen y/o sobre temas predefinidos (como las emociones en el embarazo y maternidad, transición a la maternidad, manejo del estrés posnatal, entre otros). Se busca el apoyo entre usuarias, brindar oportunidades para compartir problemas y soluciones y generar una red de apoyo. Son facilitados por el/la psicólogo/a, médicos, enfermera/o trabajadores/as sociales en los ambientes del EESS o en un ambiente de la comunidad adecuado para las participantes. Es posible la realización de esta intervención a través de medios virtuales en caso de que la presencialidad no lo permita.

iv. **Intervenciones relacionadas al aborto, muerte fetal o infantil:** Se brinda soporte a la experiencia de la pérdida basándose en el contexto cultural, circunstancias, experiencias y emociones de la usuaria (centrado en la persona). El contenido de la intervención generalmente considera el soporte necesario sobre:

M. QUISPE G.

C. DIAZ V.

- Aceptación de la pérdida.
- Duelo.
- Proyecto de vida.

Las intervenciones son realizadas por un/a profesional de la salud en los ambientes del EESS o en un ambiente apropiado para la usuaria. Se indican bajo criterio clínico de las/los terapeutas durante el tiempo apropiado a las necesidades de la usuaria.(Ver Anexo 5)

v. **Intervenciones psicoterapéuticas:** Las sesiones las realiza el/la médico especialista en psiquiatría, médico especialista en medicina familiar, médico cirujano o psicólogo, según corresponda. Se indican bajo criterio clínico durante el tiempo apropiado a las circunstancias de la usuaria. Dentro de estas tenemos:

- Terapia cognitivo – conductual (TCC): Integra las teorías cognitivas y de la conducta. Busca cambiar pensamientos y/o conductas no adaptativas para mejorar el estado emocional.
- Terapia de pareja cognitivo-conductual: Se enfoca en pensamientos desafiantes que interfieren con la comunicación saludable y la resolución de problemas y en enseñar a las parejas habilidades específicas para mejorar la comunicación, reducir los conflictos y aumentar la resolución compartida de problemas. En casos de cualquier tipo de violencia, con el fin de prevenir la revictimización, no se debe promover la realización de la presente intervención.
- Psicoterapia interpersonal (TPI): Centrada en el afecto y en las relaciones, se enfoca en experiencias interpersonales estresantes de pérdida, cambios de vida, conflictos, aislamiento social, y enfatiza el papel de las relaciones en la recuperación.
- Intervenciones motivacionales para usuarias con consumo de sustancias: Es un estilo de asesoramiento directivo y centrado en la usuaria para provocar un cambio de comportamiento al ayudarla a explorar y resolver la ambivalencia.

6.5.2. Intervenciones farmacológicas

El uso de psicofármacos se realiza tomando en cuenta las indicaciones y efectos de cada medicación, así como la evidencia sobre los riesgos sobre todo durante la gestación y la lactancia, considerando:

- Riesgos para la madre (incluidos los derivados del no tratamiento).
- Riesgo de para producir malformaciones o defectos en la descendencia.
- Riesgo de complicaciones obstétricas.
- Riesgos para el/la neonato/a.
- Riesgo de complicaciones de salud a largo plazo (en el neurodesarrollo u otros).
- La indicación de un tratamiento farmacológico debe considerar las interacciones farmacológicas con otros medicamentos o reacciones adversas a medicamentos que la paciente pueda estar tomando; por lo que, los EESS deben implementar el seguimiento fármaco terapéutico de las usuarias

(gestantes y MNN menor de 5 años) que requieran tratamiento farmacológico con psicofármacos según el Documento Técnico: Manual de Buenas Prácticas de Oficina Farmacéutica, aprobado por Resolución Ministerial N° 554-2022/MINSA o la que haga sus veces.

- Todos/as los/as profesionales de salud deben estar atentos/as a la presencia y reconocimiento precoz de los efectos adversos. Se debe explicar a la paciente las posibles reacciones adversas a los medicamentos reportadas en la literatura o no, con el fin de que esta pueda participar en el reconocimiento precoz de los mismos y su manejo.
- Todos/as los/as profesionales de salud, bajo responsabilidad, están obligados/as a reportar todas las sospechas de reacciones adversas al Centro Nacional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia (CENAFyT), según el formato correspondiente (Anexo 6). La notificación de las reacciones adversas graves debe ser realizada dentro de las 24 horas de conocido el evento, y si es leve o moderado, en un plazo no mayor de 72 horas.
- Los reportes de reacciones adversas a medicamentos tienen carácter confidencial.
- Los psicofármacos son prescritos o supervisados por el/la médico especialista en psiquiatría, médico especialista en medicina familiar, médico cirujano. Los psicofármacos se prescriben con el consentimiento informado de la usuaria, y sólo después de una cuidadosa conversación, con seguimiento y evaluación continua. Se tiene en cuenta la respuesta anterior a medicamentos similares.
- El/la médico especialista en psiquiatría o el/la médico en medicina familiar o el/el médico cirujano procura usar un sólo medicamento teniendo en cuenta la fisiología de la gestante y MNN menores de 5 años.
- A las usuarias en edad fértil que van a iniciar o reciben tratamiento con psicofármacos, se les recomienda el uso de un método anticonceptivo, hasta que deseen embarazarse, lo cual idealmente debe ocurrir durante un período de estabilidad sintomática. El/la profesional de salud que realiza la atención coordina con el servicio de salud sexual y reproductiva. En caso la usuaria desee concebir, esta debe estar precedida de una o varias consultas preconcepcionales que permitan planificar las intervenciones más convenientes según sea el caso.
- En el caso de gestantes que continúan o inician tratamiento con medicamentos antipsicóticos, deben recibir seguimiento del aumento de peso excesivo y descarte de diabetes gestacional.

6.5.3. Terapia electroconvulsiva (TEC):

Se considera como un tratamiento de última opción para casos severos de depresión o psicosis, estados afectivos mixtos severos o manía, catatonia, cuya salud física de la gestante o la del feto esté en grave riesgo, y que son refractarias a todas las intervenciones realizadas. Se realiza siempre bajo consentimiento informado y junta médica.

6.5.4. Seguimiento de las intervenciones:

Después de la evaluación inicial, se programan citas para el seguimiento, a través de oferta fija, móvil o telesalud, de acuerdo con las circunstancias de cada usuaria.

La frecuencia del seguimiento es proporcional a la complejidad clínica y psicosocial del contexto, incluye la provisión de visitas domiciliarias integrales por el equipo interdisciplinario periódicamente. Inicialmente se realizan con mayor frecuencia hasta que los síntomas empiecen a responder al tratamiento; una vez que los síntomas comiencen a mejorar, se programan citas menos frecuentes.

6.5.5. Intervenciones para situaciones específicas

En caso de gestantes y MNN menores de 5 años que presentan situaciones específicas, adicionalmente a lo descrito en el numeral 6.4.1, se considera lo siguiente, según el caso:

1) Intervenciones para depresión y/o ansiedad

- La usuaria gestante o MNN menores de 5 años con diagnóstico de depresión y/o ansiedad recibe una evaluación y seguimiento hasta lograr mejoría en la sintomatología. Posteriormente, se continúa con el seguimiento correspondiente con el fin de detectar recaída en los síntomas.
- El/la médico especialista en psiquiatría, médico especialista en medicina familiar, médico cirujano o psicólogo/a realizan las intervenciones psicoterapéuticas a la usuaria gestante y MNN menores de 5 años con riesgo de desarrollar depresión perinatal u otro problema psicosocial o trastorno mental durante la gestación y maternidad temprana.
- El personal de la salud evalúa a las usuarias que presenten depresión y/o ansiedad, promueve la presencia de soporte social de acuerdo a sus necesidades de la usuaria, que pueda acompañar, apoyar y motivar de forma cercana y oportuna.
- A todas las usuarias gestantes y MNN menores de 5 años con diagnóstico de depresión y/o ansiedad, se les ofrece ingresar al PCC.
- Toda mujer gestante o MNN menores de 5 años con diagnóstico de depresión y/o ansiedad empieza su tratamiento con psicoterapias, terapias psicosociales, psicoeducación, movilización de redes como primeras alternativas de tratamiento. Sólo se usa psicofármacos en caso de estricta necesidad, para ello se utiliza la Guía Técnica: Guía de Práctica Clínica para Tamizaje, Diagnóstico y Tratamiento de la Depresión en Personas Mayores de 18 años desde el Primer Nivel de Atención, aprobada por Resolución Ministerial N.° 136-2023-MINSA o la que haga sus veces.
- En caso que la usuaria presente pensamientos o conductas autolesivas, manía, psicosis y se han agotado otras intervenciones, se indica la hospitalización.

2) Consumo perjudicial de alcohol y drogas

- El/la profesional de la salud realiza intervenciones breves en las usuarias con trastorno por consumo de sustancias, haciendo hincapié en los riesgos del

M. QUISPE G.

C. DIAZ V.

consumo de alcohol y drogas durante la gestación.

- De identificar el uso perjudicial de alcohol o drogas durante el embarazo o período posnatal, la usuaria es referida a un CSMC o a un EESS con personal especializado para atención de trastornos por consumo de sustancias.
- A todas las usuarias que presenten trastornos por consumo de sustancias, el/la profesional de la salud evalúa y promueve la presencia de soporte socialadecuado que pueda acompañar, apoyar, motivar y auxiliar a la usuaria de forma cercana y oportuna.
- A todas las usuarias gestantes y MNN menores de 5 años con diagnóstico de trastornos por consumo de alcohol y/o drogas, se les ofrece ingresar al PCC.
- El personal de la salud realiza visitas domiciliarias para evaluación y seguimiento, al inicio de la intervención y posteriormente, de acuerdo con el criterio clínico del/de la médico especialista en psiquiatría o el/la médico en medicina familiar o la/el médico cirujano. El/la profesional de la salud ofrece a las usuarias a participar en intervenciones grupales.
- El/la médico especialista en psiquiatría, médico especialista en medicina familiar, médico cirujano o psicólogo(a) realizan las intervenciones psicoterapéuticas a la usuaria gestante o MNN menores de 5 años con trastornos por consumo de alcohol y/o drogas.
- En caso de intoxicación alcohólica, se procede según lo establecido en la Guía Técnica para la atención en salud mental para las personas con intoxicación alcohólica, aprobada por Resolución Ministerial. Nº 247-2020-MINSA o la que haga sus veces, a fin de valorar la situación de la usuaria, sus síntomas y signos clínicos, complicaciones, nivel de gravedad e intervenciones según corresponda.
- Si la usuaria no desea realizar la interrupción del consumo de alcohol se realizan intervenciones para ayudarla a reducir progresivamente su consumo a través de las intervenciones psicoterapéuticas.
- Para madres que dan de lactar:

  a) Se realiza una evaluación de riesgos ante la exposición del/de la bebé al alcohol y drogas en la leche materna, la existencia y el estado de infección por VIH, la disponibilidad de sucedáneos de la leche materna seguros y asequibles, así como el acceso a agua potable, entre otros.

  b) En el caso de un consumo excesivo y diario de alcohol (riesgo alto para el/la lactante), es preferible no dar de lactar hasta disminuir su consumo. El contactopiel con piel es importante independientemente de la elección de alimentación y se alienta activamente, siempre y cuando la madre no se encuentre intoxicada.

3) Trastornos psicóticos durante la gestación y MNN menores de 5 años.

- Las usuarias con síntomas activos de psicosis que acudan a atenderse en los EESS del primer nivel de atención no especializado son referidas al CSMC si la evaluación de sus síntomas y signos así lo requiere, y si necesitan hospitalización se refieren al hospital general del ámbito territorial, para su

atención y evaluación y tratamiento.

- En caso de usuarias con diagnóstico de psicosis sin síntomas activos, se atienden en los EESS de primer nivel no especializado y, si el caso lo amerita según gravedad, se refieren a los CSMC para su evaluación integral y tratamiento.
- Las usuarias gestantes y/o MNN de 5 años con diagnóstico de esquizofrenia o psicosis perinatal, según evaluación de gravedad de sus signos y síntomas, funcionalidad y adherencia al tratamiento se ingresan al PCC.
- El/la profesional de la salud realiza seguimiento a las usuarias, de acuerdo a la gravedad del caso, para prevenir la aparición de recaídas, especialmente si se ha interrumpido la medicación antipsicótica.
- A todas las usuarias, que presenten trastornos psicóticos, el/la profesional de la salud evalúa y promueve la presencia de soporte social adecuado que pueda acompañar, apoyar, motivar y auxiliar a la usuaria de forma cercana y oportuna.
- El/la médico especialista en psiquiatría o el/la médico en medicina familiar o el/la médico cirujano indica tratamiento intrahospitalario si la usuaria presenta pensamientos o actos autolesivos o psicosis y se han agotado otras intervenciones que procuren el bienestar de ella y sus hijos/as.
- Consideraciones con respecto al tratamiento farmacológico:

  a) Las usuarias con diagnóstico de psicosis que se embaracen y suspendan su tratamiento psicofarmacológico deben recibir seguimiento interdisciplinario, se les ofrece a ella y a su red de soporte social información clara sobre los signos de alarma de recaída (por ejemplo, trastornos del sueño, irritabilidad, disminución de la energía, pensamiento delirante, alucinaciones, entre otros). El/la médico especialista en psiquiatría o el/la médico en medicina familiar o el/la médico cirujano evalúa reiniciar los psicofármacos tan pronto se identifique una recaída.

  b) En usuarias que usen psicofármacos, se monitorea la aparición de efectos colaterales y en el caso de gestantes, referir al servicio de ginecoobstetricia para la evaluación correspondiente.

  c) Si la usuaria no acepta usar la medicación, se intensifican las intervenciones psicosociales, incluyendo la psicoeducación.

4) Conducta autolesiva o suicida en la gestación y MNN menores de 5 años.

- El/la profesional de la salud coordina con todo el equipo de salud del EESS y con otro EESS con mayor capacidad resolutiva e instituciones pertinentes (Policía Nacional del Perú-PNP y fiscalías) para brindar atención integral, oportuna a las necesidades inmediatas y mediatas de la usuaria.
- El/la profesional de la salud ofrece y motiva a la usuaria a ingresar al PCC.
- El/la profesional de la salud vigila de forma cercana la presencia y evolución de pensamientos suicidas y conductas autolesivas. Si el caso lo amerita, se

brinda tratamiento intrahospitalario, para posterior seguimiento del EESS de su territorio.

- El equipo interdisciplinario de salud efectúa intervenciones psicoterapéuticas.
- Se brinda psicoeducación y terapia de apoyo a la usuaria, su familia y otras personas importantes para la usuaria. Se incluye un plan de acción ante crisis en salud mental que contiene el acompañamiento, técnicas de relajación, cómo solicitar ayuda inmediata de las instituciones pertinentes (líneas y servicios de emergencia).
- Se realizan visitas e intervenciones domiciliarias.
- Se incorpora a la usuaria en un grupo de soporte de pares.
- De ser necesario, para preservar y/o restaurar la integridad física y emocional de la usuaria, el/la profesional de la salud la refiere a un servicio de emergencia o EESS mayor nivel, de acuerdo a la evaluación y necesidades de cada caso.
- Se ofrece un tratamiento intrahospitalario si la usuaria presenta pensamientoso intentos de daño a sí misma o a otros, manía o psicosis y se han agotado otras intervenciones que procuren el bienestar de ella y sus hijos/as.
- El/la responsable de la vigilancia de salud mental o quien haga sus veces en el EESS coordina el llenado de las fichas del registro de notificación de la vigilancia centinela en casos detectados de intento de suicidio con el/la profesional de la salud que atendió el caso.

5) Violencia intrafamiliar:

- Se realiza un plan de intervención basado en el nivel de riesgo, procurando la seguridad de la usuaria y de los/as hijos/as, de acuerdo a lo dispuesto en la Guía Técnica para la atención de salud mental a mujeres en situación de violencia ocasionada por la pareja o expareja, aprobada con Resolución Ministerial N.° 670-2021/MINSA o la que haga sus veces.
- Si la usuaria es gestante y es víctima de violencia, ingresar al PCC en el CSMC.
- Realizar visitas domiciliarias para evaluar el soporte familiar, prevenir la revictimización por agresor intradomiciliario, realizar intervenciones familiares, entre otras acciones de cuidado.
- Se le ofrece participar de grupos de apoyo entre pares.
- Si se identifica violencia durante la gestación y no ha habido aún atenciones prenatales o estos han sido irregulares, derivar a la usuaria a los servicios correspondientes para la evaluación de la salud materno-fetal.

VII. RESPONSABILIDADES

7.1 Nivel nacional

El MINSA, a través de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, mediante la Dirección de Salud Mental, es responsable de la difusión e implementación hasta el nivel regional de la presente Directiva Sanitaria, así como la, asistencia técnica, monitoreo, supervisión y evaluación.

7.2 Nivel regional

Las DIRESAs, GERESAs y DIRIS son responsables de la difusión, asistencia técnica, monitoreo, supervisión, evaluación eimplementación de la presente Directiva Sanitaria en sus respectivas jurisdicciones.

7.3 Nivel local

Los EESS son responsables del cumplimiento y aplicación de la presenteDirectiva Sanitaria, según corresponda.

VIII. ANEXOS

ANEXO 1: CUESTIONARIO SOBRE LA SALUD DEL PACIENTE-9 (PHQ-9).

ANEXO 2: GUÍA DE PREGUNTAS PARA EL TAMIZAJE DE VIOLENCIA A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE PAREJA O EXPAREJA (WAST).

ANEXO 3: CUESTIONARIO DE IDENTIFICACIÓN DE LOS TRASTORNOS DEBIDOS AL CONSUMO DE ALCOHOL (AUDIT-C)

ANEXO 4: REGISTRO DE ACTIVIDADES.

ANEXO 5: PAUTAS PARA EL MANEJO DEL DUELO PERINATAL.

ANEXO 6: FORMATO NOTIFICACIÓN DE SOSPECHAS DE REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS U OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS POR LOS PROFESIONALES DE LA SALUD

ANEXO 7: FLUJOGRAMA DE ATENCIÓN EN SALUD MENTAL A GESTANTES Y MADRES DE NIÑAS Y NIÑOS DE HASTA 5 AÑOS

ANEXO 1: CUESTIONARIO SOBRE LA SALUD DEL PACIENTE-9 (PHQ-9)

PHQ- 9: La escala autoadministrada de tamizaje y seguimiento, consta de 9 ítems y nos permite obtener un diagnóstico provisional de depresión; así como valora la severidad de los síntomas depresivosdurante las 2 semanas previas a la aplicación de esta escala

Escala de Salud del Paciente (Patient Health Questionnaire, PHQ- 9)					
En estas 2 últimas semanas ¿Usted ha sentido molestias o problemas cómo?					
N.º	**Preguntas**	**Para nada**	**Varios días (1 a 6 días)**	**La mayoría de días (7 a 11 días)**	**Casi todoslos días (12 a más días)**
1	¿Pocas ganas o interés en hacer las cosas?	0	1	2	3
2	¿Sentirse desanimada(o), deprimida(o), triste o sin esperanza?	0	1	2	3
3	¿Problemas para dormir o mantenerse dormida(o), o en dormirdemasiado?	0	1	2	3
4	¿Sentirse cansada(o) o tener poca energía sin motivo que lo justifique?	0	1	2	3
5	¿Poco apetito o comer en exceso?	0	1	2	3
6	¿Dificultad para poner atención o concentrarse en las cosas quehace?	0	1	2	3
7	¿Moverse más lento o hablar más lento de lo normal o sentirsemás inquieta(o) o intranquila(o) de lo normal?	0	1	2	3
8	¿Pensamientos de que sería mejor estar muerta(o) o que quisierahacerse daño de alguna forma buscando morir?	0	1	2	3
9	¿Sentirse mal acerca de sí misma(o) o sentir que es una(un) fracasada(o) o que se ha fallado a sí misma(o) o a su familiar?	0	1	2	3
	Sub total				
	Total				
Si usted se identificó con cualquier problema en este cuestionario, ¿cuán difícilse le ha hecho cumplir con su trabajo, atender su casa o relacionarse con otraspersonas debido a estos problemas? (Marque con una x en la casilla que mejor lo represente)		Nada en absoluto	Algo difícil	Muy difícil	Extremadamente difícil

M. QUISPE G.

C. DIAZ V.

Sumar todos los ítems y obtener un puntaje total.

Puntaje	0-4	5-9	10-14	15-19	20-27
Interpretación	Mínimo o ninguna	Síntomas depresivos leves	Síntomas depresivos moderado	Síntomas depresivos moderadame nte severo	Síntomas depresivos severos
CASOS NEGATIVO		CASOS POSITIVO			

INTERPRETACIÓN:

Los puntajes reflejan 5 categorías de severidad del trastorno depresivo:

Categoría	Puntaje
Ninguna	0-4 puntos
Leve	5-9 puntos
Moderado	10-14 puntos
Moderadamente severo	15-19 puntos
Severo	20-27 puntos

M. QUISPE G.

C. DIAZ V.

MINISTERIO DE SALUD - DGIESP
Dirección de Salud Mental
Vº Bº
DIRECTORA EJECUTIVA

ANEXO 2: GUÍA DE PREGUNTAS PARA EL TAMIZAJE DE VIOLENCIA A MUJERESEN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE PAREJA O EXPAREJA (WAST)

El siguiente listado de preguntas se presenta con la finalidad de indagar si la mujer se encuentra en situación de violencia de pareja o expareja. Esta lista de chequeo se realiza, dejando a consideración su adaptación, de acuerdo a las circunstancias y lenguaje de las usuarias, así comotambién, el/la profesional de salud puede considerar aquellas otras preguntas que estime convenientes. Se sugiere recordar a la entrevistada que la pareja está compuesta por 2 personas que tienen diferentes gustos y costumbres por lo que es natural que existan desacuerdosen la vida cotidiana.

Preguntas para relacionar el motivo de consulta con un posible maltrato:	**Para preguntar a las usuarias sobre sus relaciones de pareja o expareja:**
1. ¿Cómo se siente usted misma? 2. ¿Mantiene su apetito, sueño y deseos de realizar sus actividades como de costumbre? 3. ¿Toma algo (medicación u otro que le hayan recomendado) para sentirse mejor?	4. ¿Cómo se siente en las relaciones cotidianas con su pareja o expareja? 5. ¿Cuáles son los desacuerdos más frecuentes que se dan con su pareja o expareja? 6. ¿Cómo manejan estos desacuerdos? ¿Llegan a las discusiones? 7. Generalmente, ¿cómo terminan las discusiones con su pareja o expareja? 8. ¿Su pareja o expareja se enoja con facilidad o tiene arranques inesperados de cólera?

Para preguntar directamente a las usuarias sobre una posible violencia, el/la profesional de la salud realiza las siguientes preguntas:

Cuestionario				Puntaje
1	**En general ¿Cómo describiría su relación de pareja?**			
	Estresante (3 p)	Un poco estresante (2 p)	Nada estresante (1 p)	
2	**Usted y su pareja resuelven las discusiones con:**			
	Mucha dificultad (3p)	Algo de dificultad (2p)	Sin dificultad (1p)	
3	**Al terminar las discusiones usted ¿Se siente decaída o mal con usted misma?**			
	Muchas veces (3p)	A veces (2p)	Nunca (1p)	
4	**Las discusiones ¿terminan en golpes, patadas o empujones?**			
	Muchas veces (3p)	A veces (2p)	Nunca (1p)	
5	**¿Hay situaciones en las cuales ha sentido miedo de las reacciones de su pareja?**			
	Muchas veces (3p)	A veces (2p)	Nunca (1p)	

M. QUISPE G.

C. DIAZ V.

6	**Su pareja ¿controla el dinero que usted gasta, o la obliga a realizar trabajo en exceso?**			
	Muchas veces (3p)	A veces (2p)	Nunca (1p)	
7	**Su pareja ¿la insulta, grita, humilla o descalifica verbalmente?**			
	Muchas veces (3p)	A veces (2p)	Nunca (1p)	
8	**¿Se ha sentido obligada a tener relaciones sexuales con su pareja para evitar problemas?**			
	Muchas veces (3p)	A veces (2p)	Nunca (1p)	
	PUNTAJE TOTAL			

INTERPRETACIÓN:

	Punto mínimo	Puntaje máximo
Tamizaje positivo	>15	24
Tamizaje negativo	8	15
Si una o más preguntas 4, 6 y 7 son (+), inclusoaunque total fuera < de 14 (asegurada la comprensión de las preguntas)		**Caso de violencia confirmado – Tamizaje positivo.**

Si el tamizaje resulta positivo, se procede de acuerdo con la Guía Técnica para el cuidado de la salud mental de mujeres en situación de violencia ocasionada por la pareja o expareja, aprobada Resolución Ministerial N° 670-2021/MINSA o la que haga sus veces.

ANEXO 3: Cuestionario de Identificación de los Trastornos debidos al Consumo deAlcohol

(AUDIT-C)

Lea las preguntas tal como están escritas. Registre las respuestas cuidadosamente. Empiece el AUDIT diciendo «Ahora voy a hacerle algunas preguntas sobre su consumo de bebidas alcohólicas durante el último año». Explique qué entiende por «bebidas alcohólicas» utilizando ejemplos típicos como cerveza, vino, pisco, etc. Codifique las respuestas en términos de consumiciones («bebidas estándar»). Marque la cifra de la respuesta adecuada en el recuadro de la derecha. Cada una de las preguntas tiene una serie de respuestas a elegir y cada respuesta tiene una escala de puntuación de 0 a 4. Al final, todas las puntuaciones de las respuestas se suman y anota en el cuadro denominado "Total". Se usan unas puntuaciones totales iguales o mayores a 4 como indicadores de consumo de riesgo
1. ¿Con cuanta frecuencia toma una bebida que contiene alcohol? (0) Nunca (1) Una vez al mes o menos (2) 2 – 4 veces al mes (3) 2 – 3 veces a la semana (4) 4 o más veces a la semana
2. ¿Cuántas bebidas con alcohol toma en un día típico en que bebe? (0) 1 o 2 (1) 3 o 4 (2) 5 o 6 (3) 7, 8, o 9 (4) 10 o más
3. ¿Con cuánta frecuencia toma seis o más bebidas en una sola ocasión? (0) Nunca (1) Menos de una vez al mes (2) Una vez al mes (3) Una vez por semana (4) A diario o casi a diario
PUNTUACIÓN TOTAL:

INTERPRETACIÓN

El AUDIT-C se califica en una escala de 0 a 12 puntos (puntajes de 0 indican ningún uso de alcohol).

En hombres, una puntuación de 4 o más es considerada significativa (o "positiva"); en mujeres, se considera significativa una puntuación de 3 o más. Un puntaje significativo ("positivo") indica que la persona está en riesgo elevado de consumo perjudicial o abusivoo dependencia de alcohol.

ANEXO 4: REGISTRO DE ACTIVIDADES

Considerar los siguientes códigos para el registro de la actividad:

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Tamizaje en Violencia	96150.01
Tamizaje en Alcohol y Drogas	96150.02
Tamizaje en Trastornos Depresivos	96150.03
Consejería de Prevención de riesgos en salud mental	99402.09
Problemas relacionados con violencia	R456
Problemas Sociales Relacionados con el Uso de Alcohol	Z721
Pesquisa de Problemas Relacionados a la salud mental	Z133

En caso la usuaria tenga la condición de gestante, registrar en se registrará en el 2do valor lab del diagnóstico la siguiente sigla:

VALOR LAB	CONDICIÓN
G	Gestante

Registro de tamizaje en trastornos

depresivosTamizaje negativo:

En el ítem: Ficha Familiar/Historia Clínica, anote DNI del usuario
En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, anote claramente:
- En la 1º fila anote el código de tamizaje de trastorno depresivo.
- En la 2º fila anote Consejería de Prevención de riesgos en salud mental.
- En el ítem: Tipo de Diagnóstico marque la columna "D".

DIA	D.N.I.	FINANC.	DISTRITO DE PROCEDENCIA	EDAD	SEXO	PERIMETRO CEFALICO Y ABDOMINAL	EVALUACION ANTROPOMETRICA HEMOGLOBINA	ESTABLEC	SERVICIO	DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD	TIPO DE DIAGNÓSTICO			VALOR LAB			CÓDIGO CIE / CPT
	HISTORIA CLINICA	10	12														
	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO								P	D	R	1º	2º	3º	
NOMBRES Y APELLIDOS PACIENTE:				FECHA DE NACIMIENTO: ___/___/___						FECHA ULTIMO RESULTADO DE Hb: ___/___/___				FECHA DE ULTIMA REGLA: ___/___/___			
08	04453577	2	Lima	39	A M D	PC	PESO	N	N	1. Tamizaje en Trastornos Depresivos	P	D	R				96150.03
	5895				M	Pab	TALLA	C	C	2. Consejería de Prevención de riesgos en salud mental	P	D	R				99402.09
					F		Hb	R	R	3.	P	D	R				

Tamizaje positivo:

En el Ítem: Ficha Familiar/Historia Clínica, anote DNI del usuario

En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, anote claramente:

- En la 1º fila anote el código de tamizaje de trastorno depresivo
- En la 2º fila anote Pesquisa de problemas relacionados a la salud mental
- En la 3º fila anote Consejería de Prevención de riesgos en salud mental En el ítem: Tipo de Diagnóstico marque la columna "D".

DIA	D.N.I.	FINANC.	DISTRITO DE PROCEDENCIA	EDAD	SEXO	PERIMETRO CEFALICO Y ABDOMINAL	EVALUACION ANTROPOMETRICA HEMOGLOBINA	ESTABLEC	SERVICIO	DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD	TIPO DE DIAGNÓSTICO			VALOR LAB			CÓDIGO CIE/CPT
	HISTORIA CLINICA																
	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO								P	D	R	1º	2º	3º	
NOMBRES Y APELLIDOS PACIENTE:				(*)FECHA DE NACIMIENTO: ___/___/___						FECHA ULTIMO RESULTADO DE Hb: ___/___/___				FECHA DE ULTIMA REGLA: ___/___/___			
8	04453575	2	Lima	32	A M D	PC	PESO	N	N	1. Tamizaje en Trastornos Depresivos	P	D	R				96150.03
	5875				M	Pab	TALLA	C	C	2. Pesquisa de problemas relacionados a la salud mental	P	D	R				Z133
					F		Hb	R	R	3 Consejería de Prevención de riesgos en salud mental	P	D	R				99402.09

M. QUISPE G.

Registro de tamizaje en dependencia del alcohol

Tamizaje negativo:

En el ítem: Ficha Familiar/Historia Clínica, anote DNI del usuario

En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, anote claramente:

- En la 1º fila anote el código de tamizaje en dependencia de alcohol.
- En la 2º fila anote Consejería de Prevención de riesgos en salud mentalEn el ítem: Tipo de Diagnóstico marque la columna "D".

C. DIAZ V.

Tamizaje positivo:

En el Ítem: Ficha Familiar/Historia Clínica, anote DNI del usuario

En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, anote claramente:

- En la 1º fila anote el código de tamizaje en dependencia de alcohol
- En la 2º fila anote Pesquisa de problemas relacionados a la salud mental.
- En la 3º fila anote Consejería de Prevención de riesgos en salud mental.

Mod. Psic. July Esther Caballero Portella V°B° DIRECTORA EJECUTIVA

• En el ítem: Tipo de Diagnóstico marque la columna "D".

DIA	D.N.I. / HISTORIA CLINICA / GESTANTE/PUERPERA	FINANC. / ETNIA	DISTRITO DE PROCEDENCIA / CENTRO POBLADO	EDAD	SEXO	PERIMETRO CEFALICO Y ABDOMINAL	EVALUACION ANTROPOMETRICA HEMOGLOBINA		ESTABLEC	SERVICIO	DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD	TIPO DE DIAGNÓSTICO P	D	R	VALOR LAB 1º	2º	3º	CÓDIGO CIE/CPT
NOMBRES Y APELLIDOS PACIENTE:				(*)FECHA DE NACIMIENTO: ___/___/____							FECHA ULTIMO RESULTADO DE Hb: ___/___/____				FECHA DE ULTIMA REGLA: ___/___/____			
8	04453575 / 5875	2	Lima	32	A / D	PC / Pab	PESO		N	N	1. Tamizaje en Alcohol y Drogas	P	X	R				96150.02
							TALLA				2. Problemas Sociales Relacionados con el Uso de Alcohol	P	X	R				Z721
					F		Hb		R	R	3 Consejería de Prevención de riesgos en salud mental	P	X	R				99402.09

Sólo se está considerando el tamizaje en alcohol

Registro de tamizaje en violencia

Tamizaje negativo:
En el Ítem: Ficha Familiar/Historia Clínica, anote DNI del usuario
En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, anote claramente:
• En la 1º fila anote el código Tamizaje en Violencia
• En la 2º fila anote Consejería de Prevención de riesgos en salud mental
• En el ítem: Tipo de Diagnóstico marque la columna "D".

DIA	D.N.I. / HISTORIA CLINICA / GESTANTE/PUERPERA	FINANC. / ETNIA	DISTRITO DE PROCEDENCIA / CENTRO POBLADO	EDAD	SEXO	PERIMETRO CEFALICO Y ABDOMINAL	EVALUACION ANTROPOMETRICA HEMOGLOBINA		ESTABLEC	SERVICIO	DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD	TIPO DE DIAGNÓSTICO P	D	R	VALOR LAB 1º	2º	3º	CÓDIGO CIE/CPT
NOMBRES Y APELLIDOS PACIENTE:				(*)FECHA DE NACIMIENTO: ___/___/____							FECHA ULTIMO RESULTADO DE Hb: ___/___/____				FECHA DE ULTIMA REGLA: ___/___/____			
8	04453575 / 5875	2	Lima	32	A / D	PC / Pab	PESO		N	N	1. Tamizaje en Violencia	P	X	R				96150.01
							TALLA				2. Consejería de Prevención de riesgos en salud mental	P	X	R				99402.09
					F		Hb		R	R	3	P	D	R				

Tamizaje positivo:
En el Ítem: Ficha Familiar/Historia Clínica, anote DNI del usuario
En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, anote claramente:
• En la 1º fila anote Tamizaje en Violencia
• En la 2º fila anote Problemas relacionados con violencia
• En la 3º fila anote Consejería de Prevención de riesgos en salud mental
• En el ítem: Tipo de Diagnóstico marque la columna "D"

ANEXO 5: PAUTAS PARA EL MANEJO DEL DUELO PERINATAL

- La información a los padres sobre la muerte fetal o muerte del/de la recién nacido/a debe ser breve y comprensible. La información debe darse en un ambiente seguro y confidencial. Debemos cuidar nuestra expresión facial, nuestro tono de voz y las palabras que brindemos. Respetar las manifestaciones de dolor, tales como el llanto.

- La información debe darse de forma clara y pausada, puede repetirse la informacióna pedido de la usuaria, la repetición puede ser de utilidad para que los padres puedanir integrando la información e ir aceptando la realidad de la situación.

- Saber escuchar, puede ser un momento en que la madre y sus familiares deseen ser escuchados, validados, entendidos y acompañados. No juzgar las emociones e ideas de los padres.

- Se debe brindar a los padres, si lo desean, la oportunidad de estar con el/la recién nacido/a, abrazarlo, hablarle.

- En caso de muerte fetal, se les ofrece a los padres la posibilidad de poder ver el cuerpo después del parto.

- Se ofrece la posibilidad de ponerle un nombre al/a la recién nacido/a.
- Se orienta de forma clara acerca de los trámites funerarios, se ofrece ayuda en la realización de estos.

- Se informa a la familia sobre la necesidad o no de realizar la autopsia, validando sus respuestas verbales y emocionales, haciéndoles sentir que buscamos ponernos en sulugar.

- De ninguna manera recomiende en ese momento el tener un nuevo embarazo o adopción inmediata.

- Ofrecer apoyo terapéutico posterior, ya sea de forma individual y/o en grupos terapéuticos de pares con la participación del/de la profesional de la salud. Es más fácil abordar el duelo materno al compartir las vivencias con otros padres que han estado en una situación semejante y que se encuentran en otras etapas del duelo.

- Para el personal de la salud puede resultar difícil ser testigos de una muerte perinatal,pudiendo sentir impotencia, frustración y tristeza. Pedir ayuda si lo consideran necesario

ANEXO 6:
FORMATO NOTIFICACION DE SOSPECHA DE REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS U OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS POR LOS PROFESIONALES DE LA SALUD

SISTEMA PERUANO DE FARMACOVIGILANCIA Y TECNOVIGILANCIA

FORMATO
NOTIFICACIÓN DE SOSPECHAS DE REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS U OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS POR LOS PROFESIONALES DE LA SALUD

CONFIDENCIAL

A. DATOS DEL PACIENTE

Nombres o Iniciales(*):

Edad (*):	**Sexo (*)** ☐ F ☐ M	**Peso(Kg):**	**Historia Clínica y/o DNI:**

Establecimiento(*):

Diagnóstico Principal o CIE10:

B. REACCIONES ADVERSAS SOSPECHADAS:

Marcar con "X" si la notificación corresponde a :

☐ Reacción adversa ☐ Error de medicación ☐ Problema de calidad ☐ Otro(Especifique) .....

Describir la reacción adversa (*)

Fecha de inicio de RAM (*): ___/___/_____
Fecha final de RAM: ___/___/_____

Gravedad de la RAM(Marcar con X)
☐ Leve ☐ Moderada ☐ Grave

Solo para RAM grave (Marcar con X)
☐ Muerte. Fecha ___/___/_____
☐ Puso en grave riesgo la vida del paciente
☐ Produjo o prolongó su hospitalización
☐ Produjo discapacidad/incapacidad
☐ Produjo anomalía congénita

Desenlace(Marcar con X)
☐ Recuperado ☐ Recuperado con secuela
☐ No recuperado ☐ Mortal ☐ Desconocido

Resultados relevantes de exámenes de laboratorio (incluir fechas):

Otros datos importantes de la historia clínica, incluyendo condiciones médicas preexistentes, patologías concomitantes (ejemplo: Alergias, embarazo, consumo de alcohol, tabaco, disfunción renal/hepática, etc.)

C. MEDICAMENTO(S) U OTRO(S) PRODUCTO(S) FARMACEUTICO(S) SOSPECHOSO(S) (En el caso de productos biológicos es necesario registrar el nombre comercial, laboratorio fabricante, número de registro sanitario y número de lote)

Nombre comercial y genérico(*)	Laboratorio	Lote	Dosis/ Frecuencia(*)	Vía de Adm. (*)	Fecha inicio(*)	Fecha final(*)	Motivo de prescripción o CIE 10

Suspensión(Marcar con X)	**SI**	**No**	**No aplica**	**Reexposición**(Marcar con X)	**SI**	**No**	**No aplica**
(1)¿Desapareció la reacción adversa al suspender el medicamento u otro producto farmacéutico?				(1)¿Reapareció la reacción adversa al administrar nuevamente el medicamento u otro producto farmacéutico?			
(2)¿Desapareció la reacción adversa al disminuir la dosis?				(2)¿El paciente ha presentado anteriormente la reacción adversa al medicamento u otro producto farmacéutico?			

El paciente recibió tratamiento para la reacción adversa ☐ SI ☐ No Especifique:

En caso de sospecha de problemas de calidad indicar: Nº Registro Sanitario: Fecha de vencimiento___/___/_____.

D. MEDICAMENTO(S) U OTRO(S) PRODUCTO(S) FARMACEUTICO(S) CONCOMITANTE(S) UTILIZADO(S) EN LOS 3 ÚLTIMOS MESES (excluir medicamento(s) u otro(s) producto(s) farmacéutico(s) para tratar la reacción adversa)

Nombre comercial y genérico	Dosis/ frecuencia	Vía de Adm.	Fecha inicio	Fecha final	Motivo de prescripción

E. DATOS DEL NOTIFICADOR:

Nombres y apellidos(*):

Teléfono o Correo electrónico(*):

Profesión(*): **Fecha de notificación** ___/___/_____ **Nº Notificación:**

Los campos (*) son obligatorios

Correo electrónico: farmacovigilancia@digemid.minsa.gob.pe

M. QUISPE C.

C. DIAZ V.

Med. Psic. Judy Esther Cabanillas Peralta
V°B°
DIRECTORA EJECUTIVA

SISTEMA PERUANO DE FARMACOVIGILANCIA Y TECNOVIGILANCIA

INSTRUCTIVO PARA COMPLETAR EL FORMATO DE NOTIFICACIÓN DE SOSPECHAS DE REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS U OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS POR LOS PROFESIONALES DE LA SALUD

1. Notifique aunque usted no tenga la certeza de que el medicamento u otro producto farmacéutico causó la reacción adversa. La sospecha de una asociación es razón suficiente para notificar.
2. Notifique todas las sospechas de reacciones adversas conocidas, desconocidas, leves, moderadas y graves relacionadas con el uso de Productos Farmacéuticos (medicamentos, medicamentos herbarios, productos dietéticos y edulcorantes, productos biológicos, productos galénicos).
3. No deje de notificar por desconocer una parte de la información solicitada.
4. En caso de embarazo, indicar el número de semanas de gestación al momento de la reacción adversa.
5. Utilice un formato por paciente.
6. En caso de no contar con el espacio suficiente para el registro de la información, utilice hojas adicionales.
7. **Las sospechas de reacciones adversas graves deben ser notificadas dentro de las veinticuatro (24) horas de conocido el caso, y si son leves o moderadas, en un plazo no mayor de setenta y dos (72) horas y deberán ser enviadas según el flujo de notificación de acuerdo a la Norma Técnica de Salud correspondiente.**

A. DATOS DEL PACIENTE

Nombres o iniciales: Registrar los nombres o iniciales del paciente.

Edad: Expresar en número e indicar si son días, meses o años. En caso de no contar con este dato se colocará el grupo etario. Cuando se trate de anomalías congénitas informar la edad y sexo del hijo en el momento de la detección y la edad de la madre.

Sexo: Marcar con una "X" la opción que corresponda.

Peso: Indicar el peso del paciente en Kg.

Historia Clínica y/o DNI: Si se conoce colocarlo.

Establecimiento: Indicar el nombre completo del establecimiento (hospital, centro de salud, puesto de salud, farmacia/botica u otra institución) donde se detecta la RAM.

Diagnóstico principal o CIE 10: Indicar la enfermedad de base del paciente (ejemplo: Cáncer, enfermedad de Alzheimer) o su respectivo código CIE 10 (clasificación internacional de enfermedades).

B. REACCIONES ADVERSAS SOSPECHADAS

El formato también puede ser utilizado para notificar errores de medicación, problemas de calidad, u otros (uso fuera de indicación autorizada, uso del medicamento u otro producto farmacéutico durante el embarazo o lactancia, sobredosis o exposición ocupacional) si están asociadas a sospechas de reacciones adversas.

Reacción adversa: Describa detalladamente la(s) reacción(es) adversa(s) incluyendo localización e intensidad y toda la información clínica relevante (estado clínico previo a la reacción adversa, signos y/o síntomas reportados, diagnóstico diferencial) para la reacción adversa. Si se modifica la dosis, registrar la nueva dosis administrada. Indicar el desenlace de la(s) reacción(es) adversa(s) y en el caso de un desenlace mortal especificar la causa de la muerte.

Fecha de inicio de RAM: Indicar la fecha (día/mes/año) exacta en la cual inició la reacción adversa.

Fecha final de RAM: Indicar la fecha (día/mes/año) exacta en la cual desaparece la reacción adversa.

En caso de existir más de una reacción adversa, escriba la fecha de inicio y final de cada una de ellas cuando describa la reacción adversa.

Gravedad de la RAM: Marcar con "X" la gravedad de la reacción adversa. La valoración de la gravedad se realiza a todo el caso notificado.

Solo para RAM grave: en el caso de una reacción adversa grave, marcar con una "X" la(s) opción(es) correspondiente(s).

Desenlace: Marcar con una "X" la opción que corresponda.

Resultados relevantes de exámenes de laboratorio (incluir fechas): Resultados de pruebas de laboratorio usadas en el diagnóstico de la reacción adversa y, si está disponible, las concentraciones séricas del medicamento u otro producto farmacéutico antes y después de la reacción adversa (si corresponde).

Otros datos importantes de la historia clínica: Indicar condiciones médicas previas de importancia así como patologías concomitantes (ejemplo: Hipertensión arterial, diabetes mellitus, disfunción renal/hepática, etc.) u otras condiciones en el paciente (ejemplo: Alergias, embarazo: número de semanas de gestación, consumo de tabaco, alcohol, etc.)

C. MEDICAMENTO(S) U OTRO(S) PRODUCTO(S) FARMACÉUTICO(S) SOSPECHOSO(S)

Nombre comercial y genérico: Registrar el nombre comercial y genérico (DCI) indicado en el rotulado del medicamento u otro producto farmacéutico administrado incluyendo la concentración y forma farmacéutica (ejemplo: Amoxicilina 500mg tableta).

Si el medicamento u otro producto farmacéutico es genérico, no deje de mencionar el nombre del laboratorio fabricante.

Laboratorio: Colocar el nombre del laboratorio fabricante o del titular del registro sanitario.

Lote: Registrar las letras y/o números que indica el "lote" en el envase del producto.

Dosis/frecuencia: Indicar la dosis en cantidad y unidades de medida suministrada y los intervalos de administración del medicamento u otro producto farmacéutico (por ejemplo: 20 mg cada 12 horas).

Vía de administración: Describa la vía de administración del medicamento u otro producto farmacéutico (ejemplo: VO, IM, IV).

Fecha inicio y final: Indicar la fecha (día/mes/año) en que inició y finalizó o se suspendió el tratamiento con el medicamento u otro producto farmacéutico. En caso que el tratamiento continúe al momento de la notificación, colocar la palabra "Continúa".

Motivo de prescripción o CIE 10: Describa el motivo o indicación por el cual el medicamento u otro producto farmacéutico fue prescrito o usado en el paciente o su respectivo código CIE 10.

Para conocer el efecto de la suspensión y reexposición: Marcar con una "X" la opción que corresponda.

El paciente recibió tratamiento para la reacción adversa: Indicar si la reacción adversa requirió tratamiento (farmacológico, quirúrgico, etc.) y de ser positivo, especificar el tratamiento.

En caso de sospecha de problemas de calidad: Completar la información solicitada.

En el caso de productos biológicos es necesario registrar el nombre comercial, laboratorio fabricante, número de registro sanitario y número de lote.

D. MEDICAMENTO(S) U OTRO(S) PRODUCTO(S) FARMACÉUTICO(S) CONCOMITANTE(S) UTILIZADOS EN LOS 3 ÚLTIMOS MESES

Registrar el nombre comercial y genérico (DCI) de los medicamentos u otros productos farmacéuticos prescritos o automedicados utilizados en los 3 últimos meses antes de la aparición de la reacción adversa. Excluir los medicamentos u otros productos farmacéuticos usados para tratar la reacción adversa. En el caso de anomalías congénitas, indicar todos los medicamentos u otros productos farmacéuticos utilizados hasta un mes antes de la gestación. En caso de que el tratamiento continúe al momento de la notificación, colocar la palabra "Continúa".

E. DATOS DEL NOTIFICADOR

Nombres y apellidos, profesión, teléfono, correo electrónico (de contacto de la persona): Su objetivo es para solicitar información adicional y/o para canalizar una respuesta del caso notificado si es necesario.

Fecha de notificación: Indicar la fecha (día/mes/año) en que se completó el formato.

Nº notificación: Este casillero será para uso exclusivo del Centro de Referencia Regional o Institucional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia.

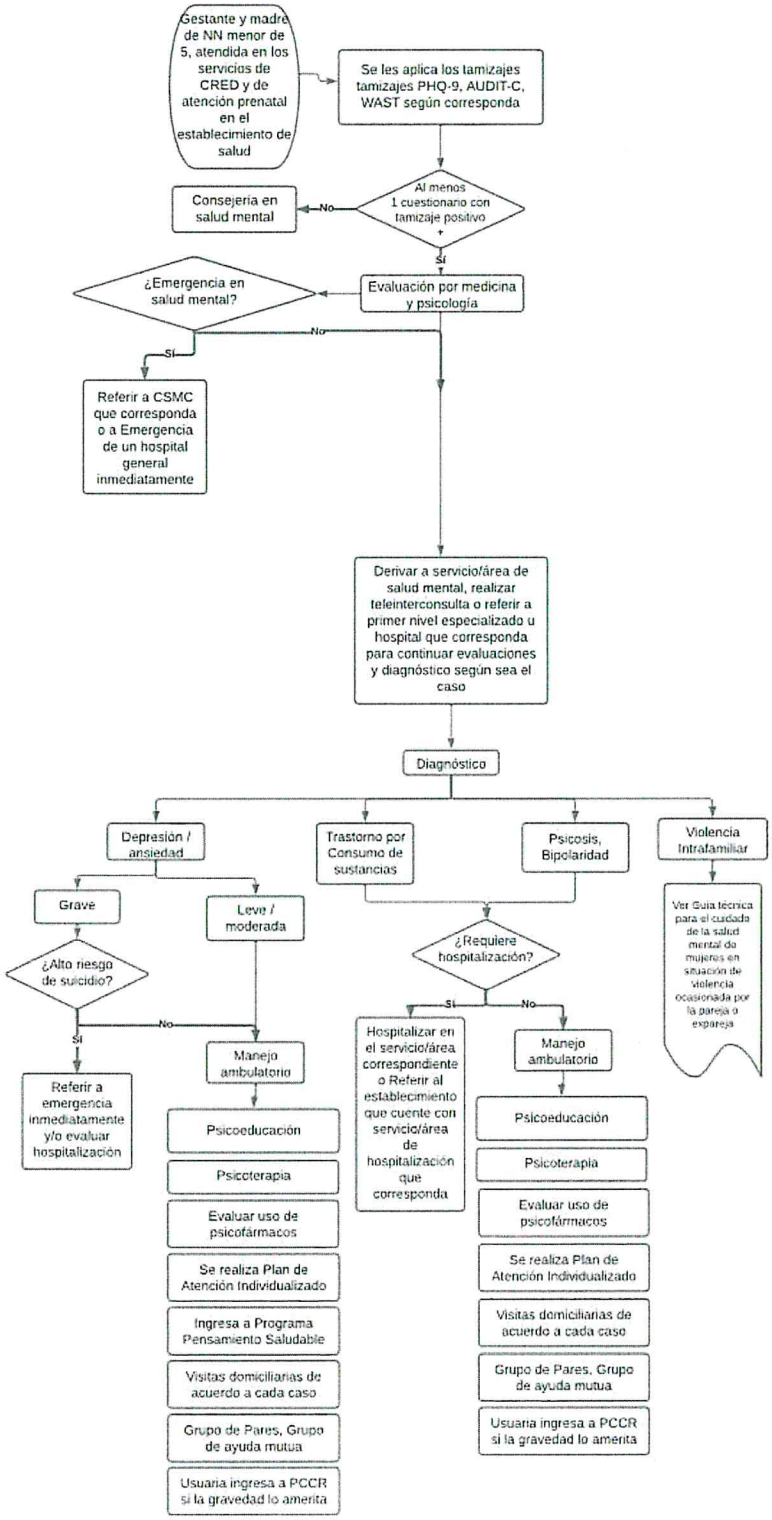
Correo electrónico: farmacovigilancia@dgiesp.minsa.gob.pe

MINISTERIO DE SALUD Dirección General de Personal de la Salud M. QUISPE G.

MINISTERIO DE SALUD C. DIAZ V.

MINISTERIO DE SALUD - DGIESP Dirección de Salud Mental Méd. Psq. Judy Esther Cabrera Pereda DIRECTORA EJECUTIVA V°B°

ANEXO 7: FLUJOGRAMA DE ATENCIÓN EN SALUD MENTAL A GESTANTES Y MADRES DE NIÑAS Y NIÑOS DE HASTA 5 AÑOS



IX. BIBLIOGRAFÍA

1) World Health Organization. Preventing suicide: A global imperative [Internet]. 2014 [citado 14 de enero de 2022]. Disponible en: https://www.who.int/publications-detail-redirect/9789241564779

2) Organización Panamericana de la Salud. Pensamiento saludable. Manual para la atención psicosocial de la depresión perinatal. [Internet]. 2015. Disponibleen: https://iris.paho.org/handle/10665.2/28417

3) Krauskopf V, Valenzuela P. Depresión perinatal: detección, diagnóstico y estrategias de tratamiento. Rev Médica Clínica Las Condes. 1 de marzo de 2020;31(2):139-49.

4) Biaggi A, Conroy S, Pawlby S, Pariante CM. Identifying the women at risk of antenatal anxiety and depression: A systematic review. J Affect Disord. febrero de 2016;191:62-77.

5) Romero-Montes AD, Sánchez-Chávez FN, Lozano-Vargas A, Ruíz-Grosso P, Vega-Dienstmaier J. Estructura de la sintomatología psiquiátrica según el SRQ-18 en pacientes ambulatorios con trastornos mentales evaluados en un hospital general de Lima. Rev Neuro-Psiquiatr. julio de 2016;79(3):142-51.

6) Vega-Dienstmaier JM, Mazzotti Suárez G, Campos Sánchez M. Validación de una versión en español de la Escala de Depresión Postnatal de Edimburgo. Actas Esp Psiquiatr. 2002;30(2):106-11.

7) Binfa Esbir L, Cancino V, Ugarte I, Mella Guzmán M, Cavada Chacón G. Adaptación del instrumento WAST para la detección de violencia doméstica en Centros de Salud. Rev Médica Chile [Internet]. marzo de 2018 [citado 20 de mayo de 2021]; Disponible en: http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/152316

8) Maldonado-Durán JM (Ed), Organización Panamericana de la Salud. Salud Mental Perinatal [Internet]. OPS; 2011 [citado 17 de abril de 2021]. Disponible en: https://iris.paho.org/handle/10665.2/51594

9) Thoma N, Pilecki B, McKay D. Contemporary Cognitive Behavior Therapy: A Review of Theory, History, and Evidence. Psychodyn Psychiatry. septiembrede 2015;43(3):423-61.

10) Cluxton-Keller F, Bruce ML. Clinical effectiveness of family therapeutic interventions in the prevention and treatment of perinatal depression: A systematic review and meta-analysis. PLOS ONE. 14 de junio de 2018;13(6):e0198730.

11) Ravitz P, Watson P, Lawson A, Constantino MJ, Bernecker S, Park J, et al. Interpersonal Psychotherapy: A Scoping Review and Historical Perspective (1974-2017). Harv Rev Psychiatry. junio de 2019;27(3):165-80.

12) Payne JL. Psychopharmacology in Pregnancy and Breastfeeding. Med Clin North Am. julio de 2019;103(4):629-50.

13) Kulkarni J, Storch A, Baraniuk A, Gilbert H, Gavrilidis E, Worsley R. Antipsychotic use in pregnancy. Expert Opin Pharmacother. junio de

2015;16(9):1335-45.

14) Organización Panamericana de la Salud. Guía de intervención mhGAP para los trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias en el nivel de atención de salud no especializada. Versión 2.0 [Internet]. 2017. Disponible en: https://iris.paho.org/handle/10665.2/34071

15) Smit M, Dolman KM, Honig A. Mirtazapine in pregnancy and lactation - A systematic review. Eur Neuropsychopharmacol J Eur Coll Neuropsychopharmacol. enero de 2016;26(1):126-35.

16) Kulkarni J, Storch A, Baraniuk A, Gilbert H, Gavrilidis E, Worsley R. Antipsychotic use in pregnancy. Expert Opin Pharmacother. junio de 2015;16(9):1335-45.

17) Eappen BS, Aguilar M, Ramos K, Contreras C, Prom MC, Scorza P, et al. Preparing to launch the «Thinking Healthy Programme» perinatal depression intervention in Urban Lima, Peru: experiences from the field. Glob Ment Health Camb Engl. 2018;5:e41.

18) Páez Cala ML, Arteaga Hernández LF. Duelo por muerte perinatal. Necesidad de una atención diferencial e integral*. Arch Med. 2019;32-45.

M. QUISPE G.

C. DIAZ V.